



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN KINERJA BULAN MEI
INSTALASI GIZI
TAHUN 2026**

I. SDM

I.1. Ketenagaan

Jabatan	Jumlah SDM			Ket.
	Standar	MEI 2026	Kebutuhan	
Ka. Penunjang Medik	1	1	0	Lampiran
Ka. Unit	1	1	0	Lampiran
Pelaksana Gizi	4	4	0	Lampiran
Pelaksana Dapur	10	10	0	Lampiran

I.2. Pemenuhan Kualifikasi SDM

Jabatan	Pendidikan		Sertifikasi				Keterangan
	Standar	Kondisi saat ini	PPI dasar	Komunikasi Efektif	Penanggulangan Bencana	BHD	
Ka. Unit	D3/S1	D3	+	+	+	+	Internal
Pelaksana	D3 D4 S1	D3 D4 S1	+	+	+	+	Internal
Penyaji	SMA/K	SMA/K	+	-	+	+	Internal
Pengolahan	D1, SMA/K	SMP/S MA/K	+	-	+	+	Internal
Pemorsian	D1, SMA/K	SMA/K	+	-	+	+	Internal

I.3. Orientasi

Tidak ada orientasi karyawan baru pada Bulan Mei 2026

I.4. Pendidikan dan Pelatihan

Tidak terdapat diklat pada Bulan Mei 2026

I.5. Evaluasi kinerja Staf

Dilakukan evaluasi kinerja baik SDM maupun pelayanan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan cara OPPE oleh bagian SDM setiap 1 semester.

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

No.	Kegiatan Pengembangan Pelayanan	Rincian Kegiatan
1.	QC sesuai sistem HACCP	a. Pelatihan HACCP dilakukan oleh seluruh Ahli Gizi. b. Memastikan proses quality control makanan sesuai standar. c. Memastikan 7 prinsip HACCP.

No.	Kegiatan Pengembangan Pelayanan	Rincian Kegiatan
		d. Koordinasi dengan SDM jika ada informasi terkait pelatihan tersebut.
2.	Pemesanan diet melalui Whatsapp dan spreadsheet	a. Memastikan proses pemesanan diet lebih efisien dan mengurangi kesalahan pemesanan diet. b. Ahli gizi mengkonfirmasi diet di grup whatsapp jika ada penambahan diet/ganti diet saat selesai visitasi di ruangan. c. Proses cetak label langsung efisien sesuai dengan diet ter update

III. KINERJA PRODUKTIVITAS

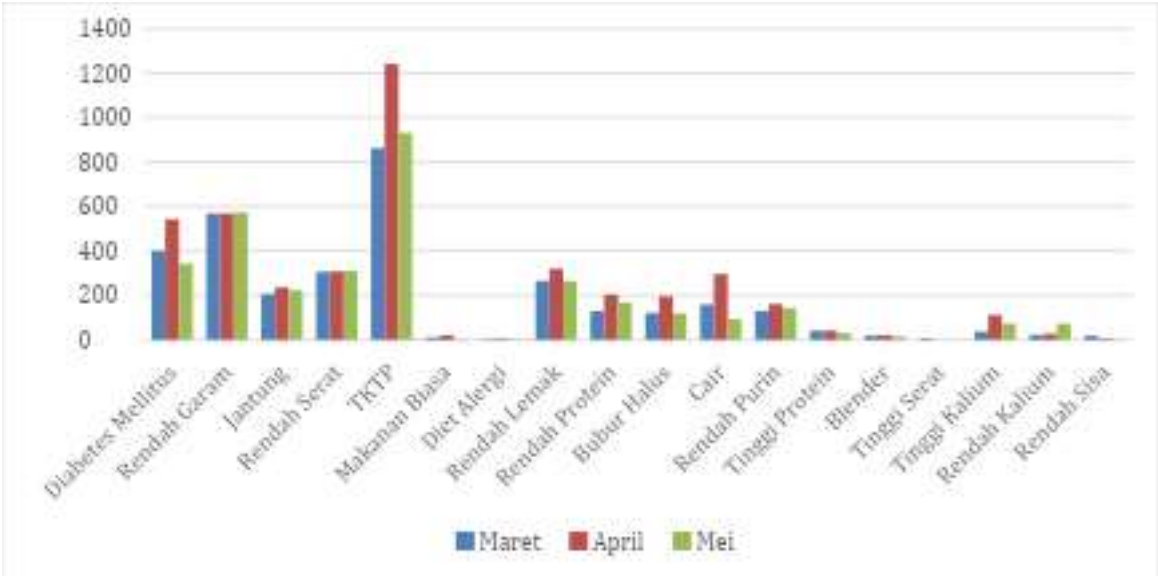
III.1. Pemberian Diet Pasien

(Perhitungan berdasarkan data pemberian diet pasien di rawat inap)

Tabel 3.1. Jumlah Pesanan Diet pada Bulan Mei Tahun 2026

No	Nama Diet	Jumlah pesanan diet			Persentase terhadap bulan sebelumnya (%)
		Bulan Maret 2026	Bulan April 2026	Bulan Mei 2026	
1.	Diabetes Mellitus	400	543	342	-37,0
2.	Rendah Garam	569	569	574	0,9
3.	Jantung	206	236	223	-5,5
4.	Rendah Serat	306	308	310	0,6
5.	TKTP	863	1242	932	-25,0
6.	Makanan Biasa	11	21	3	-85,7
7.	Diet Alergi	4	6	3	-50,0
8.	Rendah Lemak	265	320	265	-17,2
9.	Rendah Protein	129	204	168	-17,6
10.	Bubur Halus	121	196	119	-39,3
11.	Cair	159	296	93	-68,6
12.	Rendah Purin	130	161	143	-11,2
13.	Tinggi Protein	41	41	29	-29,3
14.	Blender	19	21	14	-33,3
15.	Tinggi Serat	7	0	1	0,0
16.	Tinggi Kalium	37	112	73	-34,8
17.	Rendah Kalium	22	27	73	170,4
18.	Rendah Sisa	18	6	2	-66,7
Jumlah		3307	4309	3321	-22,9

Gambar 3.1 Grafik Jumlah Pesanan Diet di Unit Gizi Pada Bulan Mei 2026



Analisis : Jumlah pemesanan diet pasien rawat inap menurun seiring dengan menurunnya jumlah pasien di rawat inap. Jumlah pemesanan diet menurun 22,9% dibandingkan bulan sebelumnya. Akan tetapi ada beberapa pemesanan diet yang meningkat dibandingkan bulan lalu, diantaranya diet rendah garam, rendah serat, dan rendah kalium berkaitan dengan kondisi pasien yang banyak membutuhkan diet tersebut.

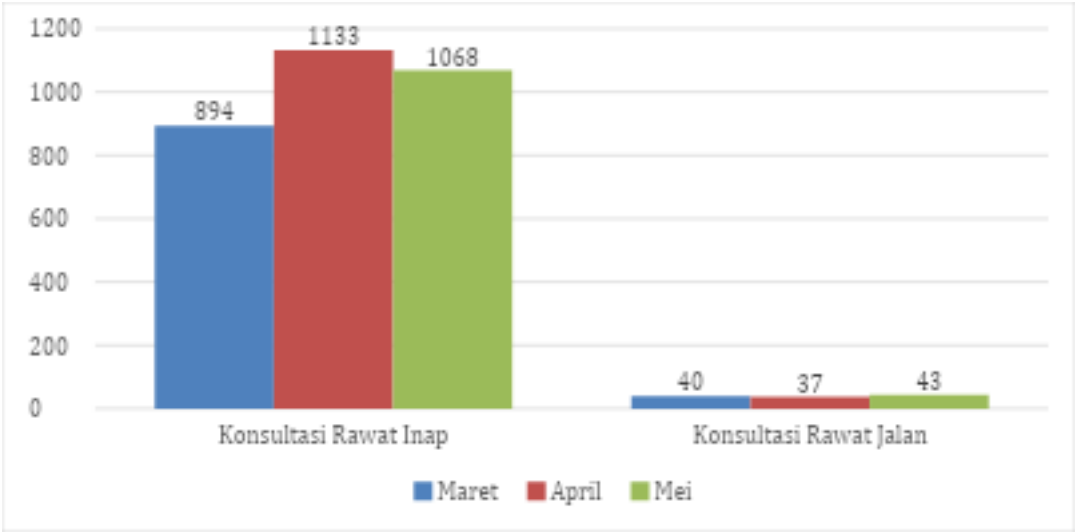
RTL : Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu dan mutu makanan dan mengajukan perubahan siklus menu. Melakukan konseling kepada karyawan perusahaan yang memiliki MOU dengan RSPHM.

III.2. Jumlah Konsultasi Gizi

Tabel 3.2 Jumlah Konsultasi Gizi

No.	Indikasi	Jumlah Pasien Maret 2026	Jumlah Pasien April 2026	Jumlah Pasien Mei 2026
1.	Konsultasi Rawat Inap	894	1133	1068
2.	Konsultasi Rawat Jalan	40	37	43

Gambar 3.2 Grafik Jumlah Konsultasi Gizi



Analisis : Jumlah konsultasi gizi rawat inap pada bulan Mei menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan bulan Mei mengalami peningkatan namun tidak signifikan dikarenakan DPJP sudah mulai aktif melakukan rujukan konseling gizi rawat jalan. Poli Spesialis yang sering merujuk pasien untuk konseling gizi adalah poli jantung (dokter Mira Sp.JP) dan poli penyakit dalam (dr. Ardhany Sp.PD, dokter Ardhi Bustami, Sp.PD dan dr.Heriyatmo, Sp.PD).

RTL : Koordinasi dengan dokter DPJP dan asisten poli spesialis agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi, selain itu koordinasi dengan tim pendaftaran dalam mempromosikan poli gizi.

III.3. Pencapaian Kinerja Gizi

Tabel 3.3. Pencapaian kinerja gizi dari Bulan Januari – Maret 2026

Kegiatan	MAR 26	APR 26	MEI 26	(Persentase terhadap bulan sebelumnya)	MEI 25	% Capaian Bulan Jan 2026 : 2025
Pemberian Diet pasien Rawat Inap	3307	4309	3321	22,9 (↓)	3570	17,9 (↑)
Konsultasi Gizi Rawat Inap	894	1133	1068	5,7 (↓))	1112	(↑)
Konsultasi Gizi Rawat Jalan	40	37	43	16,2 (↑)	20	208 (↑)

Gambar 3.3 Grafik Pencapaian Kinerja Gizi



Analisis : Konsultasi gizi rawat inap bulan Mei 2026 menurun dibandingkan bulan April. Konsultasi gizi rawat jalan bulan Mei 2026 meningkat karena beberapa DPJP sudah aktif memberikan rujukan ke poli gizi (tidak semua poli, hanya beberapa poli seperti poli jantung dan IPD) diberikan rujukan saat pasien bertanya terkait pantangan makan yang dijalankan oleh pasien saat control ke polinya.

RTL : Koordinasi dengan humas dan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat inap. Evaluasi kembali terkait kepuasan pasien terhadap variasi menu makanan. Mengajukan revisi siklus makan pasien untu meningkatkan variasi menu.

Koordinasi dengan dokter DPJP agar sering merujuk pasien nya untuk ke poli gizi dan lebih baik lagi jika ada dokter spesialis gizi. Memberikan contoh resep masakan dalam leaflet edukasi diet pasien.

III.4. Diet IRNA

Tabel 3.4. Pencapaian Kinerja Produktivitas Pemberian Diet Rawat Inap RSPHM Bulan Januari s/d Mei 2026

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SR T	TKTP	BIASA	ALERG I	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
1.	Des'25	526	580	308	349	1130	38	6	329	286	209	106	177	42	33	0	64	22	3
	Jan'26	454	561	345	237	1092	19	0	312	232	143	117	197	36	23	0	59	7	4
	Analisis	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah px yang rawat inap dengan diet tersebut meningkat	Pemberian diet rendah serat menurun karena diagnosa TF dan GEA sedikit .	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosa dengan diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Tidak terdapat pasien alergi	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mapuh	Pasien yang membutuhkan diet rendah purin meningkat seiring dengan hasil penunjang (UA) dan RPD Asam urat	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak banyak. Karena albuminnya normal .	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut tidak ada	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium menurun karena sedikit pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa karena post hemoroid agar tidak BAB dulu.

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SR T	TKTP	BIASA	ALERG I	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
												mengu nyah							

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SR T	TKTP	BIASA	ALERG I	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
2.	Jan'26	454	561	345	237	1092	19	0	312	232	143	117	197	36	23	0	59	7	4
	Feb'26	314	421	195	231	902	18	3	264	151	120	150	158	22	11	4	45	20	12
	Analisis	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Pemberian diet rendah serat menurun karena diagnosis TF dan GEA sedikit.	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosis dengan diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesad	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak banyak. Karena albuminnya normal.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut menurun.	Terdapat pasien konstipasi sehingga diet T. Serat meningkat	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium meningkat karena banyak pasien dengan diagnosis	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa meningkat karena post hemoroid atau operasi saluran cerna

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PRN	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
												aran dan tidak mapuh mengu nyah					penurun an di bulan ini	hiperkal emia.	agar tidak BAB dulu.

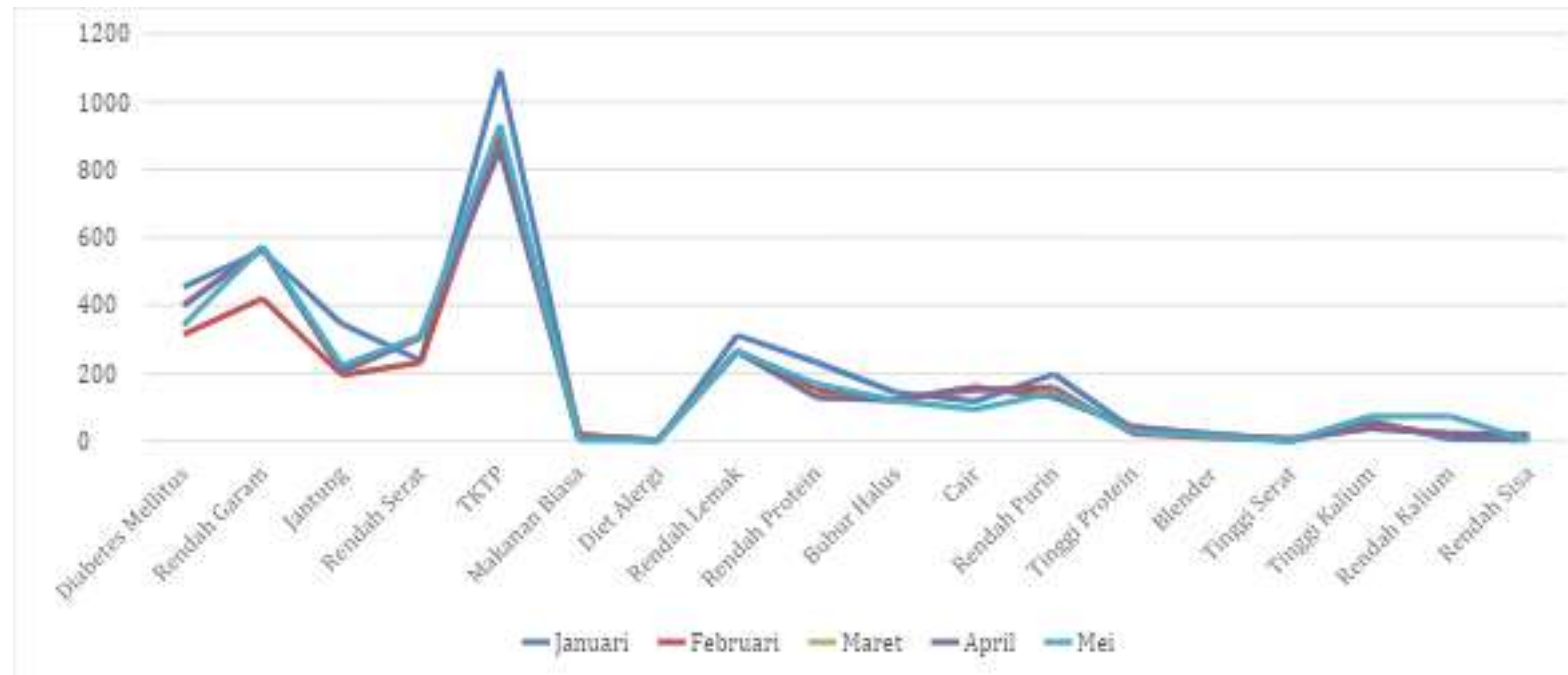
NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR N	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
3.	Feb'26	314	421	195	231	902	18	3	264	151	120	150	158	22	11	4	45	20	12
	Mar'26	400	569	206	306	863	11	4	265	129	121	159	130	41	19	7	37	22	18
	Analisis	Diet DM meningkat seiring diagnosa diabetes mellitus	Diet rendam meningkat seiring diagnosa hipertensi	Diet jantung meningkat seiring diagnosa tersebut	Pemberian diet rendah serat meningkat karena diagnosa GEA meningkat.	Pemberian diet TKTP menurun karena diagnosa dengan diet tersebut menurun	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mapuh mengunyah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut menurun.	Pasien yang butuh diet tinggi protein meningkat, Diet tersebut seiring pasien pasca bedah	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa tersebut meningkat.	Terdapat pasien konstipasi sehingga diet T. Serat meningkat	Tidak banyak pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium, karena kondisi hipokalemia. Dan mengalami penurunan di bulan ini	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium meningkat karena banyak pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa meningkat karena post hemoroid atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PR	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
4.	Mar'26	400	569	206	306	863	11	4	265	129	121	159	130	41	19	7	37	22	18
	Apr'26	543	569	236	308	1242	21	6	320	204	196	296	161	41	21	0	112	27	6
	Analisis	Pemberian Diet DM meningkat seiring diagnosis diabetes	Pemberian Diet rendah garam tidak meningkat pada bulan april	Pemberian Diet jantung meningkat seiring meningkatnya diagnosis yang	Pemberian diet rendah serat meningkat karena diagnosis GEA dan TF meningkat.	Pemberian diet TKTP meningkat karena diagnosis yang membutuhkan diet tersebut	Diet yang membutuhkan diet biasa meningkat seperti diet untuk ibu bayi dibawah 6 bulan	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pemersanan diet rendah lemak meningkat seiring dengan meningkatnya	Jumlah pasien yang membutuhkan diet rendah protein meningkat berkaitan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis yang membutuhkan diet	Pasien yang membutuhkan diet cair meningkat karena terdapat pasien yang penurunan	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis hasil lab UA tinggi meningkat.	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak meningkat	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosis tersebut meningkat yaitu pasien anak dengan usia	Tidak terdapat pasien konstipasi sehingga tidak ada pemersanan diet T. Serat	Pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium meningkat karena banyak pasien	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium meningkat karena banyak pasien dengan diagnosis	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa karena post hemoroid atau operasi saluran cerna

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PR o	B.H	CAIR	R.PRN	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
		militus		berkaitan dengan jantungg		ut meningkat yait pasien dengan operasi			a pasien dengan profil lipid yang meningkat	dengan meningkatnya hasil lab (Ur, BUN, Cr) meningkat	tersebut meningkat seperti pasien post op	unan kesad aran dan tidak mapuh mengu nyah			dibawah 6 bulan		dengan hasil lab kalium menurun	a hiperkal emia.	agar tidak BAB dulu.
5.	Apr'26	543	569	236	308	1242	21	6	320	204	196	296	161	41	21	0	112	27	6
	Mei'26	342	574	223	310	932	3	3	265	168	119	93	143	29	14	1	73	27	2
	Analisis	Pemberian Diet DM meningkat	Pemberian Diet rendah garam tidak	Pemberian Diet jantungg meningkat	Pemberian diet rendah serat meningkat	Pemberian diet TKTP meningkat karena	Diet yang membutuhkan diet biasa meningkat	Terdapat pasien dengan alergi makanan	Jumlah pasien diet rendah lemak	Jumlah pasien yang membutuhkan diet	Jumlah pasien yang rawat inap dengan	Pasien yang membutuhkan diet cair menin	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnos	Pasien yang butuh diet tinggi protein tidak	Jumlah pasien yang rawat inap dengan diagnosa	Tidak terdapat pasien konstipasi sehingga	Pasien yang membutuhkan diet tinggi kalium	Pasien yang membutuhkan diet rendah kalium	Adanya pasien yang diberikan diet rendah sisa

NO	BULAN	PEMBERIAN DIET RAWAT INAP																	
		DM	RG	DJ	R.SRT	TKTP	BIASA	ALERGI	RL	R.PRO	B.H	CAIR	R.PRN	T.Pro	Blender	T.SRT	T.KLM	R.KLM	R.SISA
		t seiring diagnosa diabetes mellitus	meningkat pada bulan april	seiring meningkatnya diagnosa yang berkaitan dengan jantung	karena diagnosa GEA dan TF meningkat.	diagnosa yang membutuhkan diet tersebut untuk meningkatkan profil pasien dengan operasi	at seperti diet untuk ibu bayi dibawah 6 bulan		meningkat seiring dengan meningkatnya pasien dengan profil lipid yang meningkat	rendahnya protein meningkat berkaitan dengan meningkatnya hasil lab (Ur, BUN, Cr) meningkat	n diagnosa yang membutuhkan diet tersebut untuk meningkatkan seperti pasien post op	gkat karena terdapat pasien yang penurunan kesadaran dan tidak mapuh mengunyah	a hasil lab UA tinggi meningkat.	meningkat	tersebut meningkat yaitu pasien anak dengan usia dibawah 6 bulan	ga tidak ada pemantauan diet T. Serat	meningkat dikarenakan banyak pasien dengan hasil lab kalium menurun	meningkat karena banyak pasien dengan diagnosa hiperkalemia.	karena post hemoroid atau operasi saluran cerna agar tidak BAB dulu.

Gambar 3.4. Grafik Pencapaian Kinerja Produktivitas Pemberian Diet Rawat Inap RSPHM Bulan Januari s/d Mei 2026



Analisis : Pada bulan Mei pemberian diet pasien sebagian besar mengalami penurunan dikarenakan menurunnya jumlah kunjungan rawat inap. Akan tetapi beberapa pemberian diet yang mengalami peningkatan adalah pemberian diet RG, Rendah serat, dan rendah kalium karena banyaknya pasien dengan keluhan terkait diagnosa tersebut.

RTL : Koordinasi dengan marketing untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien, dan meningkatkan kualitas pemberian diet pasien sesuai dengan kebutuhannya.

III.5 Permasalahan Unit

Tabel 3.5 Permasalahan Unit

NO	MASALAH	TINDAK LANJUT	
1	Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian	P	Alur penyerahan alat makanan harus bebas dari kontaminasi untuk menjamin higiene sanitasi alat makanan
		D	Kolaborasi antara ahli gizi dan IPSRS dalam pembuatan alur yang sesuai
		S	Risiko alat makan terkontaminasi makanan mentah sehingga tidak terjaga kebersihannya
		A	Tim gizi dan IPSRS berkolaborasi dalam pembuatan alur yang sesuai untuk penyerahan alat makan bersih ke tempat pemorsian
2	E-RM poli rawat jalan gizi masih belum terlaksana	P	Pemberian asuhan gizi harus dilakukan secara terintegrasi melalui penulisan CPPT
		D	Kolaborasi antara ahli gizi, programmer, dan pihak management RS dalam realisasi penulisan E-RM Poli gizi
		S	Risiko pemberian asuhan gizi tidak terintegrasi dan tidak adanya bukti ahli gizi telah melakukan edukasi kepada pasien rujukan poli dokter spesialis
		A	Tim gizi , programmer, dan pihak managemen RS dalam realisasi penulisan ERM Gizi
3	Air di Grease trap meluap	P	Mengurangi dan menghilangkan kejadian luapan air pada grease trap
		D	Melakukan pembersihan total grease trap secara rutin
		S	Risiko penumpukan lemak yang menjadi penyebab utama luapan
		A	Tim gizi, IPSRS, PPI yang bekerjasama dalam mengontrol aliran air
4	Suhu Freezer daging meningkat sehingga daging di dalam freezer tidak beku dan mengeluarkan bau menyengat	P	Menurunkan suhu freezer daging sehingga memperpanjang masa simpan daging dan menjaga kualitas daging agar tidak busuk
		D	Melakukan koordinasi dengan tim IPSRS untuk mengatur settingan freezer agar suhu freezer sesuai dengan standar yaitu $\leq -5^{\circ}\text{C}$
		S	Risiko daging sapi mengalami pembusukan

		A	Tim gizi, IPSRS, yang bekerjasama dalam mengontrol suhu penyimpanan daging
--	--	---	--

IV. FASILITAS KESEHATAN DAN K3

IV.1. Fasilitas Kesehatan

4.1.1 Inventaris alat Unit Gizi

Tabel 4.1.1.a Inventaris alat Unit Gizi (Kantor Gizi)

No .	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Monitor (Set Pc)	1	Baik	-	-
2.		Cpu (Set Pc)	1	Baik	-	-
3.		Keyboard (Set Pc)	1	Baik	-	-
4.		Printer	1	Baik	-	-
5.		Smoke Detector	1	Baik	-	-
6.		AC (1 PK)	1	Baik	-	-
7.		Mouse	1	Baik	-	-
8.	Non medis – Non Listrik	Kursi Kantor Roda	1	Rusak	-	Melakukan pembusakan ulang kursi kantor roda kolaborasi dengan tim MFK
9.		Kursi Plastik Coklat	3	Baik	-	-
10.		Kursi Plastik Hijau	2	Baik	-	-
11.		Meja Kerja	1	Baik	-	-
12.		Lemari Rak File	2	Baik	-	-
13.		Lemari Kayu	1	Baik	-	-
14.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
15.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
16.		Papan IPD	1	Baik	-	-
17.		Box File	4	Baik	-	-
18.		Laci Plastik Atk Mini	1	Baik	-	-
19.		Cutter	1	Baik	-	-
20.		Double Tape	1	Baik	-	-
21.		Gunting	1	Baik	-	-
22.		Isolasi Bening	3	Baik	-	-
23.		Kalkulator	1	Baik	-	-
24.		Odner Hitam	5	Baik	-	-
25.		Karada Scan Body Composition	1	Baik	-	-
26.		Rak Plastik Susun 4	1	Baik	-	-
27.		Plong-Plongan	1	Baik	-	-
28.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-

Ruang Poli Gizi						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	AC	1	Baik	-	-
2.		Monitor	1	Tidak pakai		
3.	Non medis –Non Listrik	Meja Kerja	1	Baik	-	-
4.		Kursi Kerja	1	Baik	-	-

5.		Kursi Pasien	2	Baik	-	-
6.		Box Food Model	1	Baik	-	-
7.		Food Model	1 set	Baik	-	-
8.		Lemari Penyimpanan	1	Baik	-	-
9.		Tumpeng Gizi Seimbang	1	Baik	-	-
10.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
11.		Microtoa	1	Baik	-	-
12.		Wastafel	1	Baik	-	-

Tabel 4.1.1.b Inventaris Alat Unit Gizi (Dapur)

Ruang Pencucian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Dishwasher	1	Baik	-	-
2.		Kipas Angin	2	Baik	-	-
3.		Exhaust Fan 40x40	1	Baik	-	-
4.	Non medis – Non Listrik	Kitchen Sink Greasetrap	1	Baik	-	-
5.		Rak Besi Susun 4	1	Baik	-	-
6.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
7.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
8.		Tray cuci	5	Baik	-	-
9.		Bak Peniris	3	Baik	-	-
10.		Gas Duck Roaster	1	Baik	-	-
11.		Heavy Duty Rice Cooker	1	Baik	-	-

Ruang Penerimaan Bahan Makanan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Showcase polytron	1	Baik	-	-
2.		Kipas Angin	1	Baik	-	-
3.		Insect Killer	1	Baik	-	-
4.	Non medis – Non Listrik	Kitchen Sink	2	Baik	-	-
5.		Rak Besi Susun 3	1	Baik	-	-
6.		Meja Penerimaan	1	Baik	-	-
7.		Loker Petugas Dapur	1	Baik	-	-
8.		Wastafel	1	Baik	-	-
9.		Timbangan Besi Duduk	1	Baik	-	-
10.		Timbangan Analog	1	Baik	-	-
11.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
12.		Rak Barang 5 Susun	1	Baik	-	-
13.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
14.		Box K3	1	Baik	-	-
15.		Tirai pvc	1	Baik	-	-

Ruang Pemorsian						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Insect Killer	2	Baik	-	-
2.		AC	1	Baik	-	-
3.		Sealer	1	Baik	-	-
3.		Meja Pemorsian Besi	6	Baik	-	-
4.		Piring Makan Persegi Melamin Pasien Vip	40	Baik	-	-
5.		Mangkok Kecil Melamin	78	Baik	-	-
6.		Box Makan Pasien Dewasa	178	Baik	-	-
7.		Box Makan Pasien Anak	28	Baik	-	-
8.		Plato Makan Pasien Anak	10	Baik	-	-
9.		Plato makan anak	68	Baik	-	-
10.		Gelas Pasien	122	Baik	-	-
11.		Tutup gelas	108	Baik		
12.		Sendok Pasien	154	Baik	-	-
13.		Sendok Snack	38	Baik		
14.	Non medis – Non Listrik	Mangkok Dokter	62	Baik	-	-
15.		Piring makan pasien persegi	52	Baik	-	-
16.		Piring snack persegi	79	Baik	-	-
17.		Mangkuk sayur	102	Baik	-	-
18.		Box makan merah	178	Baik	-	-
19.		Piring dessert	12	Baik	-	-
20.		Gelas melamin dokter	13	Baik	-	-
21.		Gelas keramik dokter	24	Baik	-	-
22.		Bel	1	Baik	-	-
23.		Thermohygrometer	1	Baik	-	-
24.		Wastafel	1	Baik	-	-
25.		Tempat Tisu	1	Baik	-	-
26.		Troli Makanan	9	Baik	-	-
29.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-

Ruang Penyimpanan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Freezer Midea	1	Baik	-	-
2.		Freezer Modena	1	Baik	-	-
3.		Showcase Politron	1	Baik	-	-
4.		Kipas Angin Kdk	1	Baik	-	-
5.		Exhaust	3	Baik	-	-
6.		Kipas Angin Miyako	1	Baik	-	-
7.	Non medis –Non Listrik	Tray Pvc	1	Baik	-	-
8.		Thermohygrometer	4	Baik	-	-

Ruang Penyimpanan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
9.		Lemari Rak Susun 4	4	Baik	-	-
10.		Ember Penyimpanan Beras	1	Baik	-	-
11.		Ember Penyimpanan Gula	1	Baik	-	-
12.		Box Kontainer Hitam	8	Baik	-	-
13.		Box Kontainer Transparan	8	Baik	-	-
14.		Toples Besar Transparan	2	Baik	-	-

Ruang Pengolahan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
1.	Non Medis – Listrik	Magic Com	2	Baik	-	-
2.		Showcase Cooler merk GEA	1	Baik	-	-
3.		Blower	1 set	Baik	-	-
4.		Oven	1	Baik	-	-
5.		Blender	2	Baik	-	-
6.		Food Prosesor	1	Baik	-	-
7.		Insect Killer	1	Baik	-	-
8.	Non medis –Non Listrik	Rak Besi Susun 3	3	Baik	-	-
9.		Meja Besi Pengolahan	1	Baik	-	-
10.		Meja Kompor	1	Baik	-	-
11.		Kompor Rinai 2 Tungku	1	Baik	-	-
12.		Kompor Besar 1	1	Baik	-	-
13.		Kompor Stockpot	2	Baik	-	-
14.		Kitchen Sink	2	Baik	-	-
15.		Timbangan Digital	1	Baik	-	-
16.		Tempat Sampah	1	Baik	-	-
17.		Panci Besar	6	Baik	-	-
18.		Panci Kecil	4	Baik	-	-
19.		Apron	15	Baik	-	-
20.		Presto	3	Baik	-	-
21.		Peniris Minyak	5	Baik	-	-
22.		Termos Nasi Besar	4	Baik	-	-
23.		Pisau	16	Baik	-	-
24.		Talenan	3	Baik	-	-
25.		Spatula	9	Baik	-	-
26.		Cetakan Pukis	2	Baik	-	-
27.		Sendok Sayur	4	Baik	-	-
28.		Baskom Besar	2	Baik	-	-
29.		Baskom Kecil	2	Baik	-	-

Ruang Pengolahan						
No.	Klasifikasi	Nama Alat	Jumlah	Kondisi	Kode Inventaris	Ket
30.		Wajan	10	Baik	-	-
31.		Baki Pasien	23	Baik	-	-
32.		Teflon	3	Baik	-	-
33.		Telepon Dapur	1	Baik	-	-
34.		Lemari Kayu	1	Baik	-	-
35.		Tirai Pvc	1	Baik	-	-
36.		Toples plastic 1500 ml	3	Baik	-	-

4.1.2 Kalibrasi

Tabel 4.1.2 Kalibrasi Alat

No.	Nama Alat	No. Seri	Frekuensi			Terakhir Kalibrasi	PJ
			Minggu	Bulan	Tahun		
1.	-						

4.1.3 Penambahan alat baru

Tabel 4.1.3 Penambahan Alat baru

No.	Nama Alat	Jumlah	No. Inventaris	No. Seri	Tanggal Pengajuan	Tanggal Barang Datang
1.	-	-	-	-	-	-

4.1.4 Alat rusak

Tabel 4.1.4 Alat Dan Fasilitas Rusak

No.	Nama Alat	Jumlah	No. Inventaris	No. Seri	Penyebab Rusak	Tanggal Lapor	Tanggal Selesai
1.	-	-	-	-	-	-	-

IV.2. GEDUNG DAN BANGUNAN

Tabel 4.2 Gedung dan Bangunan

No.	Nama Unit	Luas Gedung (M²)
1.	Instalasi Gizi	12,9 x 8,57
2.	Ruang Trolly Makanan	5,35 x 2,5

No.	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1.	Pemeliharaan alat & bangunan	a. Pada bulan ini dilakukan pembersihan rutin ruangan setiap hari. b. Dilakukan perbaikan sealer pemorsian karena sealer tidak bekerja sesuai fungsi.

No.	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
		c. Ruang pemorsian yang ada saat ini tidak sesuai karena berada di lorong (akses jalan) hal tersebut sangat tidak disarankan karena akses jalan menjadi 1 arah, sementara standar bangunan di unit gizi harus 2 arah (pintu masuk dan keluar dibedakan). d. Ruang persiapan (untuk mempersiapkan bahan makanan dari pemotongan hingga siap diolah), selama ini petugas jika memotong sayuran dll dilakukan di ruang penerimaan bahan makanan dikarenakan belum tersedianya ruang persiapan. e. Belum tersedianya ruang perpustakaan mini di unit gizi guna menunjang ilmu terupdate terkait gizi. f. Alur penyerahan alat makan bersih ke ruang pemorsian masih belum standar karena melewati ruang pengolahan g. Gudang kering masih belum sesuai standart jarak rak dari dinding.
2.	Perbaikan sarana & prasarana	a. Ruang persiapan (untuk mempersiapkan bahan makanan dari pemotongan hingga siap diolah), selama ini petugas jika memotong sayuran dll dilakukan di ruang penerimaan bahan makanan dikarenakan belum tersedianya ruang persiapan. b. Belum tersedianya ruang perpusatakaan mini di unit gizi guna menunjang ilmu terupdate terkait gizi. c. Alur keluar masuk petugas gizi atau petugas lain yang akan ke unit gizi 1 arah yaitu melalui pintu pencucian peralatan makan pasien dan ruang pengolahan makanan. d. Alur penyerahan alat makan bersih dari pencucian central sebaiknya dibuatkan jalur khusus agar langsung menuju ruang pemorsian

IV.3. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tabel 4.3. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

No.	Kegiatan Pokok	Jumlah	Keterangan
1.	Monitoring Kesehatan	-	a. Terdapat pemeriksaan kesehatan pada bulan Januari 2026 (rectal swab) b. Tidak dilakukan imunisasi pada bulan ini.
2.	PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	-	a. Pemberian makanan tambahan di berikan setiap hari Jum'at (Jum'at Berkah) b. Pemberian buka puasa dan takjil untuk seluruh karyawan shift MD dan sore setiap bulannya c. Pemberian PMT kepada unit khusus seperti unit radiologi dan unit isolasi lantai 5
3.	Mangkir Kerja		
	a. Cuti	-	-
	b. Sakit	1	Petugas penyaji (Tiyas ninda) sakit tanggal 11-12 mei, rawat inap 14-16 mei, istirahat post rawat inap 17-19 mei 2026
	c. Alpha	-	-
4.	Konseling	-	Konseling kedisiplinan karyawan kepada ahli gizi (Nafisah) terkait seragam yang tidak sesuai ketentuan dan kedisiplinan karyawan
5.	Penyakit akibat kerja /kecelakaan kerja	-	-

Analisis :

1. Pemberian makanan tambahan bagi karyawan berupa jumat berkah diberikan secara rutin
2. Pemberian makanan tambahan bagi karyawan yang berbuka puasa diberikan dengan cara karyawan yang berpuasa melakukan pemesanan makanan buka 1 hari sebelum berbuka.
3. Pemberian makanan tambahan juga diberikan kepada unit berisiko seperti unit radiologi.
4. Konseling penyimpanan makanan setengah matang diberikan karena masih terdapat petugas yang tidak disiplin memberikan tanggal pembuatan makanan setengah matang, dan matang dan belum patuh pelabelan.
5. Konseling penggunaan APD dikarenakan masih ada petugas yang tidak disiplin dalam menggunakan APD masker bagi tim pengolahan dan penyaji serta seragam bagi tim pengolahan.
6. Konseling PPI, peningkatan kemampuan pegawai dan merefresh materi setiap minggunya.

RTL :

1. Sosialisasi kepada seluruh petugas instalasi gizi (Ahli gizi, pengolahan, dan penyaji) untuk menjaga kesehatan dengan cara istirahat cukup dan memperbaiki pola makan agar tidak gampang terkena penyakit.

- 2. Sosialisasi pemberian label pada makanan setengah matang sebagai pengaktifan sistem FIFO agar makanan yang dibuat lebih dulu dapat digunakan lebih dulu untuk mencegah makanan setengah matang rusak dan dapat berdampak pada mutu makanan secara rasa dan tampilan
- 3. Sosialisasi penggunaan APD untuk melindungi diri dan melindungi makanan agar terjaga kebersihannya

V. MUTU

Tabel 5.1. Hasil Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Gizi

No.	Pengukuran	Standar	Hasil
1.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	66,7%
2.	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%
3.	Angka kelengkapan pengkajian gizi	100%	99,7%
4.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	1
5.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	1
6.	Kejadian makanan basi	0	0

Analisis :

- 1. Tanggal 24 Mei pkl 07.17 Pasien ICU a/n Suliani DPJP doker ardhi memberikan diet cair diabetasol 6x100cc/NGT akan tetapi AG Nafisah memberikan diet cair (DM RG RL R.Protein R.Kalium) tetapi diet tidak sempat diberikan kepada pasien karena pasien puasa/NGT
- 2. Tanggal 29 Mei 2026 Px Dian Indriani (D7A7) Ditemukan benda asing kecoak kecil di snack roti bolu pasien. Penyaji tyas mengakui sudah memorsi snack sejak semalam. Kemungkinan kecoak masuk pada malam hari. Sedangkan penyaji wiwin memberikan snack tanpa melihat dengan teliti dan diberikan kepada pasien. Keluarga pasien komplain kepada perawat 7a dan perawat melaporkan kepada ahli gizi.
- 3. Terdapat 3 ERM pasien KRS namun tidak dikerjakan oleh Ahli gizi Veni. Petugas gizi alfira sudah mengingatkan untuk dikerjakan terlebih dahulu karena pasien rencana pulang. Tetapi oleh ahli gizi veni tidak dikerjakan sehingga asuhan gizi pasien tidak dikerjakan sampai pasien KRS.

RTL :

- 1. Memberikan teguran berupa evaluasi kinerja kepada tim pengolahan terkait ketidak patuhan dalam menggunakan masker
- 2. Memberikan teguran berupa evaluasi kinerja kepada penyaji terkait ketidak patuhan dalam mempersiapkan snack pasien
- 3. Melakukan evaluasi terkait pemetaan ruangan saat keliling ruangan agar dapat mendahulukan pasien yang akan pulang untuk dilakukan pengkajian gizi agar tidak ada pasien yang terlewat dalam pemberian pengkajian gizi

VI. Manajemen Risiko

No	Jenis Risiko	Grading Risiko	Pengendalian Risiko	Jumlah Kejadian	Keterangan
Keselamatan					
1	Stress Kerja	Tinggi	Sosialisasi beban kerja	0	-
2	Terjatuh	Tinggi	Lantai tidak licin dan penandaan risiko	0	-
3	Terkena minyak panas	Tinggi	Penggunaan APD	0	-
4	Tersengat listrik	Tinggi	Penandaan risiko dan kabel rapih	0	-
5	Tersayat ATK	Moderate	Kewaspadaan petugas	0	-
Keamanan					
6	Terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR	0	-
7	Kehilangan	Moderate	Adanya lemari terkunci	0	-
B3					
8	Tumpahan B3 ATK	Ringan	Penyediaan spilkit B3	0	-
9	Tumpahan cairan B3	Tinggi	Pengamanan ruang yang aman	0	-
10	Kebocoran Gas	Tinggi	Pengamanan ruang yang aman	0	-
Kebakaran					
11	Konsleting listrik	Tinggi	Pemeriksaan listrik berkala	0	-
12	Kompor terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR	0	-
13	Bahan kimia mudah terbakar	Tinggi	Penyediaan APAR yang aman	0	-
Kedaruratan Bencana					
14	Kebakaran	Tinggi	Penyediaan fire protektive	0	-

15	Gempa Bumi	Tinggi	Gedung yang aman dan adanya jalur evakuasi yang mudah	0	-
16	Keracunan Makanan	Tinggi	Pemilahan bahan makanan yang bersih dan sesuai	0	-
Sistem Utilitas					
17	Kegagalan Listrik	Tinggi	Penggunaan genset	0	-
18	Kegagalan air bersih	Tinggi	Back up air bersih	0	-
19	Kegagalan jaringan internet	Ringan	Back up jaringan internet	0	-
20	Kegagalan SIMRS	Ringan	Back up data manual	0	-
Penanganan Darurat Bencana					
21	Tidak tahu alur dan proses kewaspadaan penanganan bencana	Moderate	Pelatihan dan sosialisasi manajemen penanganan penanggulangan bencana disaster	0	-
Konstruksi dan Renovasi					
22	Tembok retak	Tinggi	Pembangunan yang sesuai	0	-
23	Plafon retak	Tinggi	Pembangunan yang sesuai	0	-
24	Ruangan sempit	Ringan	Pembangunan yang sesuai	0	-
25	Ventilasi kurang	Moderate	Pembangunan yang sesuai	0	-
Pelatihan					
26	Tidak mengikuti pelatihan bencana	Moderate	Mengikuti pelatihan sesuai prosedur dan SPO yang berlaku	0	-
27	Tidak ada pelatihan boga	Moderate	Mengikuti pelatihan sesuai	0	-

			prosedur dan SPO yang berlaku		
28	STR dan SIP mati	Moderate	Perpanjangan STR dan SIP	0	-
Lingkungan					
29	Adanya semut	Tinggi	Area bersih dan pemberian perangkap	0	-
30	Adanya tikus	Tinggi	Area bersih dan pemberian perangkap	0	-

Tabel 5.2. Laporan Insiden Keselamatan / Manajemen Risiko

No	Jenis IKP	Ringkasan Kronologi & Tindak Lanjut
1.	KNC	Tanggal 24 Mei pkl 07.17 Pasien ICU a/n Suliani DPJP dokter ardhi memberikan diet cair diabetasol 6x100cc/NGT akan tetapi AG Nafisah memberikan diet cair (DM RG RL R.Protein R.Kalium) tetapi diet tidak sempat diberikan kepada pasien karena pasien puasa/NGT
2.	KTC	Pasien dengan DPJP Ahmad Farid Wajdi, Sp. dengan diagnosa CVA SUSP HEMORAGIC Atas nama DIAN INDRIANI. Ditemukan benda asing (kecoak) pada snack pasien (roti bolu), Penyaji tyas mengakui sudah memorsi snack sejak sore tanggal 28/05/2026 kemungkinan kecoak masuk pada malam hari. pada pagi hari tanggal 29/05/2026 skitar pukul 09.15 dibagiakan oleh penyaji wiwin tanpa dilihat dengan teliti jika terdapat kecoak dan diberikan ke pasien, keluarga pasien komplain kepada perawat lt 7a dan perawat melaporkan ke karu (echa) Penyaji: Tyas dan wiwin

Analisis :

- Insiden tersebut termasuk KNC karena sudah dilakukan pengkajian gizi dan penentuan diet yang tidak sesuai dengan advice DPJP tetapi diet tidak diberikan kepada pasien karena pasien puasa

RTL :

- Memberi edukasi kepada ahli gizi agar lebih berhati-hat9i dalam menentukan diet pasien.

VII. PPI

Tabel 6.1. Data Hasil Monitoring Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi di Unit Gizi Maret-Mei 2026

No.	Komponen PPI	Mar		Apr		Mei	
		Y	T	Y	T	Y	T
1.	Penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien	V		V		V	
2.	Proses pemesanan makanan pasien sesuai dengan status gizi dan kebutuhan pasien serta dicatat di rekam medis	V		V		V	
3.	Makanan yang disiapkan dan disimpan dengan mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan		V	V		V	
4.	Distribusi makanan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan	V		V		V	
5.	Jika ada keluarga pasien yang membawakan makanan, beri edukasi kepada keluarga tentang pembatasan diet pasien dan resiko kontaminasi serta pembusukan sesuai dengan regulasi	V		V		V	
6.	Pemberian terapi gizi terintegrasi pada pasien beresiko gizi	V		V		V	
7.	Asuhan gizi terintegrasi mencakup rencana, pemberian, dan monitor terapi gizi	V		V		V	
8.	Evaluasi dan monitoring terapi gizi dan dicatat di rekam medis pasien	V		V		V	
9.	Penulisan PPA dan staf klinis melakukan pengisian e-RM dengan lengkap dan jelas	V		V		V	
10.	Pelaksanaan penyimpanan, pengolahan, pemorsian, termasuk packing, distribusi, pencucian alat makan dan alat masak serta kebersihan dan sanitasi dapur	V		V		V	
11.	Pelaksanaan penyimpanan bahan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi resiko infeksi		V	V		V	
12.	Pengisian suhu ruangan, suhu lemari pendingin, suhu freezer, dan pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur	V		V		V	
13.	Kesesuaian <i>hand hygiene</i> setiap selesai melakukan kegiatan yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan <i>hand wash</i> dan <i>hand rubs</i>		V	V		V	
14.	Kelengkapan fasilitas <i>hand hygiene</i> antara lain sabun, desinfektan, serta tissue / handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan desinfeksi tangan	V			V		V
15.	Pelaksanaan pelatihan tentang <i>hand hygiene</i> untuk semua petugas gizi	V		V		V	

No.	Komponen PPI	Mar		Apr		Mei	
		Y	T	Y	T	Y	T
16.	Kepatuhan penggunaan APD	V			V		V
17.	Ketersediaan alat pelindung diri / APD	V		V		V	
Prosentase		82,3%		88,2%		88,2%	

Tabel 6.2. Kepatuhan PPI di Unit Gizi Tahun 2026

No.	Bulan	Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan		Audit Kepatuhan Pemakaian APD Unit
		Capaian OPP	Prosentase	Prosentase
1.	Januari	216	81,02%	100%
2.	Februari	288	81,25%	95%
3.	Maret	207	79,23%	96%
4.	April	216	81,94%	99%
5.	Mei	216	75,46%	99%

Sumber : Link PPI audit HH dan surveilens mutu SIMRS

Analisis :

- 1) Petugas penjamah makanan sudah mulai menerapkan 5 momen cuci tangan, harus saling mengingatkan agar terbiasa menerapkan 5 momen cuci tangan. Agar pencapaian HH meningkat.
- 2) Beberapa petugas penyaji masih belum hafal 6 langkah cuci tangan yang benar
- 3) Kepatuhan penggunaan APD bulan Juni 2026 perlu lebih ditingkatkan pada petugas pengolahan. APD yang paling sering tidak digunakan adalah masker dan seragam.
- 4) Setiap seminggu sekali diadakan refresh terkait PPI.

RTL :

- 1) Kepatuhan penggunaan APD harus lebih di disiplinkan untuk menjaga makanan tetap higienis terutama petugas pengolahan.
- 2) Kepatuhan petugas dapur dan juga penjamah makanan harus lebih ditingkatkan lagi agar dikemudian hari tidak ada kontaminasi silang ke pasien karena ketidak patuhan petugas dengan cara sosialisasi pentingnya HH dan 5 momen.
- 3) Membersihkan lingkungan dapur setiap selesai kegiatan, meletakkan bahan makanan yang baru datang di tempat yang sudah ditentukan (bahan basah dimasukkan ke gudang beku, bahan kering dimasukkan kedalam gudang kering) dengan system FIFO dan FEFO.

VIII. PKRS

Tabel 7.1 PKRS Gizi

No .	EDUKASI	Target	Hasil	Media- Metode	TGL pelaksanaan	Tempat /KET
1.	Individu pasien Irna	100%	Pasien memahami edukasi yang disampaikan	Ceramah	Setiap Hari	Ruang IRNA

No .	EDUKASI	Target	Hasil	Media- Metode	TGL pelaksanaan	Tempat /KET
2.	Kelompok (penunggu, Pasien Irna, Pasien Poli, Komunitas	4x/bln	Peserta penyuluhan memahami materi yang diberikan	Ceramah	15,17,25 dan 26 Mei 2026	Ruang Tunggu Poli

Analisis :

- 1) Edukasi di rawat inap diberikan kepada setiap pasien baru masuk. Selain itu edukasi diberikan kepada pasien dengan perubahan diet atau perubahan tekstur makanan pasien.
- 2) Edukasi kelompok diberikan kepada pasien rawat jalan dan keluarga pasien di ruang tunggu poli.
- 3) Edukasi kelompok dilaksanakan setiap seminggu sekali.
- 4) Materi yang diberikan adalah materi tentang diet pasien yang diberikan secara bergantian seperti diet DM, Rendah Protein, Rendah Lemak, Rendah Garam

RTL :

- 1) Bekerjasama dengan tim PKRS agar tidak hanya memberikan edukasi di ruang tunggu pasien tetapi juga dapat dilakukan di acara komunitas rumah sakit.

IX. MONITORING DAN EVALUASI

Tabel 8.1. Rekapitulasi Hasil Supervisi

No	STANDAR AKRE	Komponen	Dilakukan		Temuan Masalah	RTL	Prosentase	Total Prosentase
			Ya	Tidak				
1	TKRS 9	Terdapat Pedoman Pengorganisasian unit	√		Pedoman pengorganisasian sudah tersusun	-	100%	100%
		Terdapat Pedoman Pelayanan Unit	√		Pedoman pelayanan unit sudah tersusun	-	100%	
		Terdapat SPO Unit	√		SPO unit sudah tersusun	-	100%	
2	KPS 4	Terdapat SPK Bagi Ahli Gizi	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki SPK	-	100%	100%
		Terdapat RKK Bagi Ahli Gizi	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki RKK	-	100%	
3	KPS 5	Terdapat Evaluasi Kinerja Staf	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki evaluasi kinerja	-	100%	100%
4	KPS 6	Setiap Anggota Instalasi gizi memiliki file kepegawaian	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki file kepegawaian	-	100%	100%

		Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi staf (Ijazah Pendidikan terakhir)	√		5 dari 5 ahli gizi memenuhi Pendidikan, kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi staf (Ijazah Pendidikan terakhir)	-	100%	
		Uraian tugas staf	√		-	-	100%	
		Penilaian kinerja staf	√		-	-	100%	
		Salinan sertifikat pelatihan di dalam maupun di luar rumah sakit yang telah diikuti.	√		-	-	100%	
		Informasi kesehatan yang dipersyaratkan, seperti vaksinasi/ imunisasi, hasil medical check up.	√		-	-	100%	
5	KPS 17	Melakukan Kredensial bagi Tenaga Kesehatan Lain	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki sudah melalui Kredensial bagi Tenaga Kesehatan Lain	-	100%	100%

		Bukti kredensial dicantumkan di file kepegawaian	√		5 dari 5 ahli gizi memiliki Bukti kredensial	-	100%	
6	MFK 6	Pencegahan kebakaran,melalui cek pemasangan regulator elpiji, ketersediaan isi gas elpiji	√		-	-	100%	100%
		penyediaan titik evakuasi yang aman serta tidak terhalang apabila terjadi kebakaran	√		-	-	100%	
		Penyediaan sistem peringatan dini secara pasif meliputi alarm kebakaran	√		-	-	100%	
		Penyediaan fasilitas pemadaman api secara aktif meliputi APAR, hidran, sistem sprinkler	√		-	-	100%	
		Melakukan pembersihan cerobong asap dan blower secara berkala	√		Pembersihan fasilitas dapur dilakukan setiap hari oleh CS pantry	-	100%	
		Pencegahan kebakaran,melalui cek pemasangan regulator elpiji, ketersediaan isi gas elpiji	√		Cek pemasangan regulator dilakukan setiap hari untuk mencegah kebocoran gas penyebab kebakaran	-	100%	

7	PMKP 4.1	Pasien yang mendapat diet sesuai	√		-	-	100%	91,73%
		Kejadian adanya benda asing dalam makanan	√		-	-	100%	
		Kejadian pasien tidak mendapat makan	√		-	-	100%	
		Kelengkapan pengkajian gizi	√		-	-	100%	
		Kepatuhan kebersihan tangan		√	Petugas dapur dan penjamah makanan masih ada yang jarang melakukan cuci tangan sesuai dengan 5 moment dapur	Edukasi dan pemberian teguran kepada petugas yang tidak disiplin melakukan 5 moment	75,46%	
		Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) petugas pengolahan	√		Petugas pengolahan masih ada yang tidak menggunakan masker dengan alasan sakit di telinga jika menggunakan masker terlalu lama	Edukasi dan pemberian teguran kepada petugas yang tidak disiplin menggunakan masker	66,7%	
		Kepatuhan Identifikasi pasien	√		-	-	100%	
8	PMKP 9	Adanya kejadian yang tidak diharapkan (KTD)	√		-	-	100%	98,6%

		Adanya kejadian yang tidak cidera (KTC)		√	Terdapat benda asing (kecoak kecil) di snack pasien Dian Indriani (px lantai 7). Snack dikemas H-1 pada malam hari. Petugas : tyas	Memberikan teguran kepada Tyas terkait pemorsian yang tidak sesuai dengan SPO	96,6%	
		Adanya kejadian nyaris cedera (KNC)		√	Kesalahan pencatatan pemberian diet pasien ICU a/n Suliani seharusnya diberi diet cair susu oleh ahli gizi dipesankan diet sonde (DM RG RL R.Protein R.Kalium) akan tetapi diet tidak diberikan kepada pasien karena pasien puasa post pemasangan alat ventilator	Memberikan teguran kepada Ahli gizi (Nafisah) terkait penulisan diet yang tidak sesuai dengan advice DPJP	96,6%	
		Adanya kejadian potensi cidera (KPC)	√		-	-	100%	
		Adanya kejadian sentinel	√		-	-	100%	

9	PPI 8	Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) pemilihan Bahan makanan	√		-	-	100%	98,77%
		Bahan pangan yang tidak dikemas berlabel berasal dari sumber yang jelas dipercaya, baik mutunya, utuh dan tidak rusak	√		-	-	100%	
		Bahan pangan kemasan harus mempunyai label, terdaftar atau ada ijin edar dan tidak kedaluwarsa, Pangan kemasan kaleng tidak menggelembung, bocor, penyok, dan berkarat.	√		-	-	100%	
		Jika bahan pangan tidak langsung digunakan maka bahan pangan harus diberikan label tanggal penerimaan dan disimpan sesuai dengan jenis pangan		√	Masih ada bahan makanan yang tidak diberi label saat setelah dibersihkan	Mengarahkan petugas dapur untuk segera memberikan label tanggal pembelian pada saat ditemukan tidak ada label tanggal pembelian	88%	

		Bahan mentah dari hewan harus disimpan pada suhu kurang dari atau sama dengan 4 o C. Jika tidak memiliki lemari pendingin dapat menggunakan coolbox dan coolpack atau dry ice atau es balok yang dilengkapi dengan termometer untuk memantau suhu kurang dan atau sama dengan 4 oC	√		Pada tanggal 29 Mei 2026 Freezer penyimpanan daging tidak dingin. Suhu mencapai 9,5 °C	Koordinasi dengan tim IPSRS untuk memperbaiki freezer agar suhu mencapai standar	96,7%	
		Bahan pangan beku yang tidak langsung digunakan harus disimpan pada suhu – 10°C atau di bawahnya	√		-	-	100%	
		Penyimpanan harus menerapkan prinsip First In First Out (FIFO)	√		-	-	100%	
		Setiap bahan pangan ditempatkan secara terpisah dan dikelompokkan menurut jenisnya dalam wadah yang bersih, dan tara pangan (food grade)	√		-	-	100%	
		Ada catatan keluar masuknya bahan makanan	√		-	-	100%	

		Suhu gudang bahan pangan kering dan kaleng dijaga kurang dari 25 oC		√	Suhu gudang kering naik turun antara 25 -28°C	Memberikan kipas angin didalam gudang kering dan wajib menup pintu saat keluar masuk untuk menjaga suhu gudang kering	88%	
		Semua bahan pangan hendaknya disimpan pada rak-rak (pallet) dengan ketinggian atau jarak rak terbawah kurang lebih 15 cm dari lantai, 5 cm dari dinding dan 60 cm dari langit-langit.		√	jarak rak terbawah kurang dari 15 cm dari lantai	Koordinasi dengan tim IPSRS dalam memberi jarak penyimpanan makanan 15 cm dari lantai	96,6%	
		Rutin mengisi monitoring suhu setiap ruangan di instalasi gizi	√		-	-	100%	
		Memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) pengolahan bahan makanan	√		-	-	100%	
		Bahan pangan yang akan digunakan dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir sebelum dimasak	√		-	-	100%	

	Pengolahan bahan makanan memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi	√		-	-	100%	
	Bahan pangan beku sebelum dgunakan harus dilunakkan (thawing] sampai bagian tengahnya lunak,	√		-	-	100%	
	Pangan dimasak sampai matang sempurna	√		-	-	100%	
	Tempat/wadah penyimpanan terpisah dari setiap jenis makananan dan mempunyai tutup	√		-	-	100%	
	Makanan matang tidak dicampur dengan makanan mentah	√		-	-	100%	
	Adanya sample makanan yang disimpan 1 kali 24 jam	√		-	-	100%	
	Penyajian pangan matang harus bersih dan terhlndar dari pencemaran.	√		-	-	100%	
	Pangan matang yang mudah rusak dan disimpan pada suhu ruang harus sudah dikonsumsi 4 jam setelah	√		-	-	100%	

		matang, jika masih akan dikonsumsi harus dilakukan pemanasan ulang						
		Wadah/peralatan yang digunakan harus higienis, utuh, tidak cacat atau rusak	√		-	-	100%	
		Makanan disajikan tepat menu, tepat waktu, tepat tata hidang dan tepat volume (jumlah)	√		-	-	100%	
		Ada identitas pasien pada setiap box makanan pasien	√		-	-	100%	
10	PPI 11	Cek kesesuaian hand hygiene setiap selesai melakukan kegiatan yang mencakup kapan, dimana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan hand wash dan hand rubs	√		Petugas penjamah makanan masih belum disiplin dalam melakukan hand hygiene	Memberikan teguran dan Sosialisasi tentang hand hygiene kepada penjamah makanan.	81,94%	91,44%
		Cek kelengkapan fasilitas hand hygiene antara lain sabun, desinfektan, serta tissu/ handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan desinfeksi tangan	√		-	-	100%	

		Cek pelaksanaan pelatihan tentang hand hygiene untuk semua petugas gizi	√		-	-	100%	
11	PPI 11.1	Cek pelaksanaan pelatihan tentang penggunaan APD untuk semua petugas gizi	√		-	-	100%	100%
		Cek kepatuhan penggunaan APD	√		-	-	66,7%	
		Cek ketersediaan alat pelindung diri/ APD	√		-	-	100%	
12	PP 1.2	Adanya regulasi tentang kriteria risiko nutritional	√		-	-	100%	100%
		Adanya bukti Rekam Medis pengkajian awal skrining risiko nutrisi.	√		-	-	100%	
		Bukti Rekam Medis pengkajian gizi untuk pasien dengan risiko nutrisional.	√		-	-	100%	

Analisis :

-
1. Dari hasil supervise terkait regulasi yang berkaitan dengan pelayanan gizi tidak ditemukan temuan khusus yang bertentangan dengan regulasi pelayanan gizi dengan prosentase 100%.
 2. Dari hasil supervise terkait Sarana dan prasarana RS ditemukan jarak penyimpanan bahan makanan kering dari lantai kurang dari 15 cm dan perlu segera ditindaklanjuti agar masa simpan bahan makanan lebih lama
 3. Dari hasil supervisi tentang PMKP didapatkan ketidakpatuhan penggunaan APD oleh petugas pengolahan sebanyak 66,7%. Jenis APD yang jarang digunakan adalah masker. Petugas jarang menggunakan masker karena dianggap gerah saat menggunakan masker.
 4. Dari hasil supervisi kepatuhan cuci tangan perlu adanya peningkatan kesadaran penjamah makanan dalam praktik hand hygiene untuk menjamin kebersihan makanan pasien
 5. Dari hasil supervisi terkait PPI patuh dalam penggunaan APD, namun belum patuh cuci tangan, pemberian label pada makanan matang tidak langsung digunakan, dan tidak disiplin dalam menutup pintu gudang kering saat keluar masuk gudang sehingga mengakibatkan suhu gudang kering tinggi.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) :

1. Pertahankan pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan gizi rumah sakit.
2. Kepatuhan dalam mengerjakan asuhan gizi di rekam medis harus dipertahankan dengan cara lebih teliti lagi, dan jika mengerjakan tidak boleh terburu-buru.
3. Mengupdate ilmu gizi dengan mengikuti pelatihan eksternal maupun internal yang diadakan oleh rumah sakit.
4. Identifikasi pasien saat memberikan edukasi, mendistribusikan makanan kepada pasien wajib dilakukan oleh seluruh petugas.
5. Kepatuhan penggunaan APD lebih ditingkatkan lagi dengan cara mengshare nama - nama petugas yang tidak patuh setiap bulannya dan data dikirimkan ke SDM.

-
6. Kepatuhan petugas dapur dan juga penjamah makanan harus lebih ditingkatkan lagi agar dikemudian hari tidak ada kontaminasi silang ke pasien karena ketidak patuhan petugas dengan cara sosialisasi pentingnya HH dan 5 momen, membersihkan lingkungan dapur setiap selesai kegiatan, meletakkan bahan makanan yang baru datang di tempat yang sudah ditentukan (bahan basah dimasukkan ke gudang beku, bahan kering dimasukkan kedalam gudang kering) dengan system FIFO dan FEFO.
 7. Kepatuhan dalam pengisian form keluar masuk alat makan harus dihitung dengan benar dan tidak boleh dirapel, mengshare nama petugas yang tidak patuh dalam pengisian.
 8. Kepatuhan dalam mengembalikan tirai PVC setelah membersihkan area gizi agar tirai tidak rusak karena di singkap dan diletakkan dengan posisi tidak pada tempatnya.
 9. Kepatuhan dalam pengisian suhu ruangan tidak boleh dirapel, agar hasil yang didapat valid dan jika ada masalah bisa segera di TL. Mengshare nama petugas yang tidak patuh dalam pengisian.
 10. Review sosialisasi terkait pentingnya APD, HH dan pengisian suhu harus diberikan setiap satu bulan sekali saat rapat bulanan unit.
 11. Pintu penerimaan bahan makanan dan pintu ruang ganti karyawan wajib ditutup setelah keluar masuk, agar vector yang dari luar tidak masuk ke area instalasi gizi.

Tabel 8.2. Komplain Gizi

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Desember 2025	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026
2.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	0	1	1

	ISI KOMPLAINAN	- Pasien V2 lantai 2c bernama Zhafran Alkhairy (5 Februari 2026) mendapatkan menu perkedel pada hari tersebut. Keluarga pasien komplain terkait perkedel yang asam. Dan menu penunggu untuk pasien VIP mengapa sama dengan makan pasien.		
	Analisis	- Pemilihan kentang yang baik berpengaruh pada hasil matang, karena banyak ditemukan kentang yang datang bertekstur lunak saat setelah dikupas. - Mengkaji dan memberi usulan menu kepada pemegang kebijakan.		
	RTL	- Memilih dan menerima bahan makanan basah sesuai spesifikasi - Mengajukan usulan menu baru kepada pemegang kebijakan disertakan dengan bukti.		
No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Januari 2026	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026	Jumlah Komplain Bulan Maret 2026
3.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1	1	2
	ISI KOMPLAINAN	- Pasien 4A atas nama Bu Krisna komplain makan pagi tidak ada nasi. - Pasien 4A atas nama Pak Jahman komplain makanan bekas pasien lain diberikan kepada pasien.		
	Analisis	- Tidak dilakukan check ulang sesudah pemberian nasi. - Penyaji Tiyas kehabisan makanan untuk pasien baru, sehingga meminta kepada penyaji Dwi Ratna untuk meminta cadangan makan lantai yang dibagi. Dwi Ratna memberikan cadangan makan tanpa dicek dahulu. Dan penyaji Tiyas menerima tanpa mencheck dahulu juga, sehingga box makan diterima pasien dalam keadaan sudah dimakan.		
	RTL	- QC makanan sebelum ditutup, harus dilakukan double QC.		

		- Perlu adanya check ulang sebelum pendelegasian kepada teman, dan teman yang menerima harus melakukan check ulang kembali.
--	--	---

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Februari 2026	Jumlah Komplain Bulan Maret 2026	Jumlah Komplain Bulan April 2026
1.	Makanan yang disajikan dan penjelasan mengenai menu makanan.	1	2	0
	ISI KOMPLAINAN	- Tidak ada komplain terkait makanan pada bulan april		
	Analisis	-		
	RTL	-		

No.	Keluhan	Jumlah Komplain Bulan Maret 2026	Jumlah Komplain Bulan April 2026	Jumlah Komplain Bulan Mei 2026
1.	Benda asing dalam makanan pasien	2	0	1
	ISI KOMPLAINAN	Keluarga pasien atas nama Dian Indriani komplain terkait ditemukannya benda asing (kecoak) pada snack pasien (roti bolu),		
	Analisis	Penyaji tyas mengakui sudah memorsi snack sejak sore tanggal 28/05/2026 kemungkinan kecoak masuk pada malam hari.		
	RTL	Memberikan teguran terkait pemorsian snack yang tidak sesuai SOP		

X. JADWAL (SCHEDULE)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XI. PENUTUP

Dari hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan petugas gizi dalam menjalankan tugasnya sudah cukup baik sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah sakit. Namun untuk petugas penjamah makanan perlu dilakukan supervise lebih lanjut secara berkala agar kepatuhan dalam menggunakan APD dan kebersihan tangan dapat ditingkatkan.

Adanya monitoring secara berkala dari kepala unit maupun jajaran manajemen diatasnya dapat meningkatkan kepatuhan dari petugas unit gizi.

Mengetahui
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

Malang, 04 Juni 2026
Kepala Unit Gizi

A stylized handwritten signature in black ink, belonging to Ericha Risdawati.

Ericha Risdawati, A.Md. Gz

A. LAMPIRAN KUANTITAS SDM

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan Dasar RS						Ket.
		Standar	Kondisi saat ini	Mutu dan Keselamatan Pasien	BLS	PPI	Penanggulangan Bencana	Komunikasi Efektif	NCP (<i>Nutrition Care Process</i>)	
Ka. Penunjang Medik	-	Dokter	Bidan	-	-	-	-	-	-	-
Ka. Unit	Ericha Risdawati, AMd.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	-
Pelaksana Gizi	Veni Lestari Puri Purnami, AMd.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	Beberapa tidak ada sertifikat.
Pelaksana Gizi	Alfira Chaerunisa, S.Tr.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Gizi	Chandrawati M., S.Tr.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Gizi	Nafisah Ulfa H., S.Gz	D3/S1	D3/S1	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Suryani	D1/SMA/K	SMP	√	√	√	√	√	-	

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan Dasar RS						Ket.
		Standar	Kondisi saat ini	Mutu dan Keselamatan Pasien	BLS	PPI	Penanggulangan Bencana	Komunikasi Efektif	NCP (<i>Nutrition Care Process</i>)	
Pelaksana Dapur	Deri Untari	D1/SMA/K	SMP	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Siti Sulistyowati	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Suriyanti	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Della Karisma Zakenda	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Riski Dwi Andriani	SMA/K	SMA/K	√	√	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Dewinta Laili Rahmadia	SMA/K	SMA	√	-	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Sabrina Nasywa M	SMA/K	SMK	√	-	√	√	√	-	
Pelaksana Dapur	Duwi Ratna Yulianti	SMA/K	SMK	√	-	√	√	√	-	

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan Dasar RS						Ket.
		Standar	Kondisi saat ini	Mutu dan Keselamatan Pasien	BLS	PPI	Penanggulangan Bencana	Komunikasi Efektif	NCP (<i>Nutrition Care Process</i>)	
Pelaksana Dapur	Tiyas Ninda Ekasari	SMA/K	SMK	√	-	√	√	√	-	

Tenaga Gizi *) Ditampilkan 3 bulan terakhir

No .	Jenis Tenaga	Maret			April			Mei		
		Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total
1.	Nutrisisionis	-	5	5	-	5	5	-	5	5
2.	Dietisien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		-	5	5	-	5	5	-	5	5

Tenaga Dapur *) Ditampilkan 3 bulan terakhir

No .	Jenis Tenaga	Maret			April			Mei		
		Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total	Tidak Tetap	Tetap	Total
1.	Pengolah Makanan	2	2	4	2	2	4	2	2	4
2.	Penyajaji Makanan	6	0	6	6	0	6	6	0	6

No.	Nama	PK	Jabatan	Skill	Knowledge	Attitude							Catatan
						J	T	V	D	K	A	P	
4.	Nafisah Ulfa H, S.Gz	-	Pelaksana Gizi	B	B	B	C	B	B	B	B	B	Ahli gizi menolak bekerjasama saat persiapan susim akreditasi
5.	Suryani	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	C	C	C	B	C	Kurang dalam tanggungjawab terutama pada saat penerimaan sayur
6.	Deri Untari	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
7.	Siti Sulistyowati	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
8.	Suriyanti	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	C	B	B	B	Petugas tidak menggunakan APD masker saat bekerja
9.	Della Karisma Zakenda	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
10.	Riski Dwi Andriani	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	B	B	B	Lebih bertanggung jawab lagi jika diberi amanah
11.	Dewinta Laili Rahmadia	-	Pelaksana Dapur	C	B	B	B	C	B	B	B	B	Lebih berhati-hati saat bekerja untuk menjamin kualitas saat bekerja

No.	Nama	PK	Jabatan	Skill	Knowledge	Attitude							Catatan
						J	T	V	D	K	A	P	
12.	Sabrina Nasywa Mufida	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	C	C	C	Lebih peduli pada lingkungan sekitar
13.	Duwi Ratna Yulianti	-	Pelaksana Dapur	B	B	B	C	B	B	C	B	B	Memberi makanan tanpa mengecek dahulu, makanan sudah dimakan pasien diberikan
14.	Tiyas Ninda Ekasari	-	Pelaksana Dapur	B	C	B	C	B	C	C	B	B	Memorsi snack H-1 sehingga didalam snack pasien ditemukan benda asing yaitu kecoak

Keterangan: B = Baik
C = Cukup
K = Kurang

B. LAMPIRAN MUTU UNIT

No.	Indikator	Standar	Hasil											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

1.	Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas pengolahan	100%	100%	89,9%	87,8%	58,27%	66,7%	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kepatuhan identifikasi pasien oleh penyaji	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-
3.	Angka kelengkapan asuhan gizi	100%	99.8%	100%	100%	99,9%	99,7%	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kejadian kesalahan pemberian diet	0	2	2	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kejadian adanya benda asing dalam makanan	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
6.	Kejadian makanan basi	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

C. LAMPIRAN KEUANGAN UNIT GIZI (DAPUR)

Laporan Keuangan Unit Dapur

[illegible]

LAMPIRAN PENGELUARAN UNIT DAPUR 2026

NO	BULAN	TOTAL PENGELUARAN
1	Januari	Rp. 83.667.200
2	Februari	Rp. 76.391.500
3	Maret	Rp. 81.800.339
4	April	Rp. 67.920.334
5	Mei	Rp. 62.338.779
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	-

D. LAMPIRAN FOOD WASTE (SISA MAKANAN)

Siklus menu pada bulan Maret

No	Menu	Rincian Menu	Total Sisa Makanan (kg)			Keterangan
			Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	
1.	Karbohidrat	Nasi	57,8	68,8	74,7	75,5% dari sisa makanan berasal dari karbohidrat. Sisa KH pada bulan April 2026 meningkat 0,5% dari bulan Maret 2026. Perlu adanya evaluasi pemorsian KH pada menu pasien
		Nasi Tim	82,2	98,8	91,7	
	Total		167,2	138	166,1	
2.	Snack	Roti Kukus	0	0	0	Untuk konsumsi snack di Prima Husada Malang
		Setup Pisang	0	0	0	
		Kacang Hijau	0	0	0	
		Kue Hongkong	0	0	0	pada bulan April tidak ada sisa yang kembali dari pasien diakarenakan pasien memindahkan snack yang masih ada kedalam wadah pribadi saat pengambilan alat makan snack pasien
		Terang Bulan	0	0	0	
		Bubur Sagu	0	0	0	
		Kue Lumpur	0	0	0	
		Puding	0	0	0	
		Donat	0	0	0	
		Tahu Fantasi	0	0	0	
		Brule Bomb	0	0	0	
	Total		0	0	0	
1.	Menu 1					Menu 4 adalah menu paling tidak diminati, sisa makanan sebanyak 11,7 Kg pada bulan Maret.
	Bulan		Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	
	Pagi	Semur (Tahu, Buncis, Bakso)	2,7	3,8	4,1	
		Rolade Ayam				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sup Kemangi (Jagung, Wortel, Oyong, Kemangi)	2,6	4,5	3,8	
		Ayam Kecap				
		Tahu Bumbu Tomat				
Tambahan VIP	Telur Ceplok					

	Sore	Sup (Suun, wortel, polong, bakso)	2,4	4,2	3,7	
		Perkedel kentang ayam				
	Tambahan VIP	Ayam fillet panggang teflon				
	Total		7,7	12,5	11,6	
2.	Menu 2					
	Bulan		Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	
	Pagi	Sup (Manisah, Ayam Dadu, Wortel, Bihun)	4	4,7	3,5	
		Tahu Rempah (Remet)				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Rebus	3,9	4,6	3,7	
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Wortel, Manisah)				
		Ayam Wijen				
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Telur Gulung	3,4	4,2	3,3	
	Sore	Capjae (wortel, sawi hijau, bunga kol, bakso)				
		Telur dadar tebal				
	Tambahan VIP	Tempe goreng	11,3	13,5	10,5	
	Total					
3.	Menu 3					
	Bulan		Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	
	Pagi	Sup (wortel, Sawi Putih, Ayam Dadu)	3,9	4,2	3,7	
		Tahu Krispy				
		Abon				
	Tambahan VIP	Telur Ceplok	3,9	4	3,9	
	Siang	Sayur Asem (Wortel, Kacang Panjang, Manisah)				

		Rolade Ayam				
		Tahu Goreng				
	Tambahan VIP	Tempe Bacem				
	Sore	Sapo (tahu goreng, wortel, bakso,dedaunan, saos tiram)	3,9	0,5	3,9	
		Telur rebus				
	Tambahan VIP	Tempe goreng				
	Total		11,7	8,7	11,5	

4.					
	Menu 4				
	Bulan		Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026
	Pagi	Sayur Bobor (Selada Air, Manisah, Kemangi)	3,7	3,8	4,8
		Tahu Nugget			
		Abon			
	Tambahan VIP	Oseng Bakso Mekar			
	Siang	Sup (Oyong, Wortel, Jagung)	2,7	4,2	3,8
		Ayam Kecap			
		Jamur Krispy			
	Tambahan VIP	Tahu Bacem			
	Sore	Fuyunghai (telur, wortel,daunan)sas u polong orang	2,8	0,9	4
		Jamur goreng			
	Tambahan VIP	abon			
	Total		9,2	8,9	12,6

5.	Menu 5				
	Bulan		Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026

	Pagi	Sup (Bunga Kol, Sawi Daging, Bakso, Wortel)	3	2,7	4,5	
		Opor Tahu				
		Oper Telur				
	Tambahan VIP	Tempe Goreng				
	Siang	Sayur Bening (Bayam, Jagung, Manisah)	2,9	3,9	3,6	
		Ayam Bombay				
		Bakwan Jagung				
	Tambahan VIP	Tahu Krispy				
	Sore	Soto ayam	4	4	2,8	
		Telur rebus				
		VIP= Perkedel ayam				
	Total		10,9	9,9	10,9	
	Total Sisa Menu tanpa KH		53,3	54,2	51,7	
Total Keseluruhan dengan KH		191,3	221,8	223,5		

3.2.5.10 Tabel Rekap Food Waste pada Tahun 2026

No	Bulan	Total Makanan keluar (kg)	Total Sisa Makanan (kg)	%sisa makanan (standar <20%)
1.	Januari 2026	-	218,8	-
2.	Februari 2026	-	191,3	-
3.	Maret 2026	-	185,7	-
4.	April 2026	-	221,8	-
5.	Mei 2026	1676,6	223,5	7,5%
6.	Juni 2026		-	
7.	Juli 2026		-	
8.	Agustus 2026		-	
9.	September 2026		-	
10.	Oktober 2026		-	
11.	November 2026		-	

E. LAMPIRAN PEMANTAUAN AIR PANAS DI PENCUCIAN ALAT MAKAN



RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
Monitoring Suhu (Suhu Normal = 15° - 25° Celcius)

BULAN : MEI
TEMPAT : PENCUCIAN CENTRAL

Ruang	TANGGAL																																																					
	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18		
	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M						
Batas suhu min (°C)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15				
Batas suhu maks (°C)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25				
Nilai Suhu (°C)	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,3	24,9	26	24,9	26	27	24,6	24,7	26,9	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,6	26,4	26,5						
Inisial Staff	an	an	an	sm	sm	sm	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	CM	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm				
Supervisi Karu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V					

Ket : 1. Isi dengan angka yang sesuai pada kolom suhu (°C) sebagai tanda ukuran suhu pada tanggal tersebut, grafik secara otomatis akan terbentuk.
2. Tuliskan inisial staf yang melakukan pencatatan dan akan di supervisi (v) oleh kepala ruang setiap harinya.

19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31		
P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M	P	S	M			
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
26,3	26,5	27,3	25,8	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,8	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,8	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,8	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,8	26,4	26,5	25,8	26,4	26,5	26,3	26,5	27,3	25,8	26,4	26,5
sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an	an	an	an	sm	sm	sm	an	an	an
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

(---) Suhu ruang tidak lebih dari 25°C (---) Suhu ruang tidak kurang dari 15°C

F. LAMPIRAN KEHILANGAN/KERUSAKAN ALAT MAKAN

DATA NAMA PASIEN MENGHILANGKAN / MERUSAKKAN ALAT							
NO.	TANGGAL	RUANGAN	NAMA PASIEN	KWITANSI	DOKUMENTASI	Nama Alat	KET
DESEMBER 2025							
1	01/12/2025	C3C-3	SYABIL ISMAIL DWIFARO	-	-	GELAS	Pasien memecahkan gelas dan sudah membayar penggantian ke kasir
JANUARI 2026							
1	06/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas tiba-tiba retak, tidak layak pakai

2	12/01/2026	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.
3	13/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Gelas mengalami pemuaian saat diangkut oleh CS dan pecah di trolly.
4	17/01/2026					SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok makan sudah tidak layak pakai karena berkarat.

5	20/01/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	
6	20/01/2026	D7A-5	Bakri	-		BOX MAKAN PECAH	Pasien memecahkan box makan merah, namun pasien tidak bersedia membayar dan pulang.

7	21/01/2026	C4B-3	Amelia Novita Sari	-		SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok hilang terbawa pasien pulang
8	27/01/2025	-	-	-		TUTUP BOX ANAK	Tutup box anak sudah tidak layak digunakan, pecah dalam penggunaan berkali.

9	30/01/2026	D6A-2	Sukirno	-		SENDOK MAKAN PASIEN	Sendok hilang terbawa pasien pulang
FEBRUARI 2026							
1.	06/02/2026	-	-	-		GELAS PASIEN	Saat menuangkan teh, gelas retak. Sudah tidak layak pakai
2.	07/02/2026	C4A-2	HADI SUTRISNO			GELAS PASIEN	Pasien memecahkan gelas dan sudah dibayar

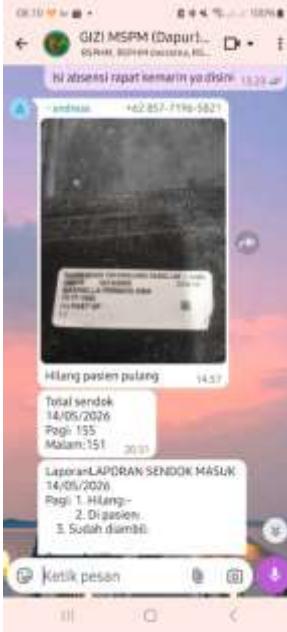
3.	15/2/2026	-	-	-		MANGKOK KECIL SNACK	Pecah oleh penyaji Tiyas
MARET 2026							
1.	08/03/2026	-	-	-		Box merah	Box merah pecah
2.	11/03/2026	D6A-12	MIFTAKHUL JANAHA			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir

3.	22/03/2026	ICU	SARMI KUSUMAWATI			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir
APRIL 2026							
4.	06/04/2026	3c Anak	GABRIAN			Gelas pasien	gelas pecah sudah lunas kasir

5.	17/04/2026	3C ANAK	M.AZMI			Gelas pasien	Pasien pulang tidak membayar kerusakan alat ke kasir
6	06/04/2026	-	-	-		gelas	gelas pecah
7	17/04/2026	-	-	-		gelas	gelas pecah

8	28/04/2026	-	-	-		box merah	Box merah pecah
---	------------	---	---	---	---	-----------	-----------------

9	17/04/2026	-	-	-		box merah	Box merah pecah
---	------------	---	---	---	---	-----------	-----------------

MEI							
10	14/05/2026	D7A-10	GABRIELLA PERMATA SINA			SENDOK MAKAN	SENDOK HILANG PASIEN PULANG TANPA MENGGANTI

11	10/05/2026	-	-	-		BOX MERAH	BOX MERAH PECAH
----	------------	---	---	---	---	--------------	-----------------

RINGKASAN LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN REKTAL SWAB PETUGAS PENJAMAH MAKANAN

Pada tanggal 22,23,30 Januari 2026, telah dilakukan pemeriksaan rectal swab pada petugas penjamah makanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang oleh Laboratorium Klinik Panglima Sudirman dengan ringkasan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PETUGAS	HASIL	KESIMPULAN	KETERANGAN
1	Siti Sulistyowati	Normal	Layak Bekerja Penjamah Makanan	Biakan <i>Staphylococcus</i> koagulase negatif
2	Sabrina Nasywa	Normal	Layak Bekerja Penjamah Makanan	Biakan <i>Escherichia coli</i>
3	Suriyanti	Normal	Layak Bekerja Penjamah Makanan	Biakan normal <i>Escherichia coli</i>
4	Riski Dwi	Tidak normal	Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
5	Della Karisma	Tidak normal	layak bekerja dengan higiene sanitasi yang ketat.	Biakan normal <i>Staphylococcus</i> koagulase positif
6	Dewinta Laili R.	Normal	Layak Bekerja Penjamah Makanan	Biakan normal <i>Escherichia coli</i>
7	Deri Untari	Tidak normal	Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
8	Surya	Tidak normal	Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
9	Tiyas Ninda Eka	Tidak normal	Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	Biakan normal <i>Salmonella sp</i>
10	Duwi Ratna Y	Tidak normal	Tidak Layak sementara, perlu pengobatan	Biakan normal <i>Salmonella sp</i>

Demikian hasil ringkasan pemeriksaan rectal swab petugas penjamah makanan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai pada lampiran hasil dan agar dapat dilakukan tindak lanjut guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit

